

DE LA HÍSTERO-EPILEPSIA

Lección XIII

Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière
Tomo I · París, A. Delahaye · Recogidas y publicadas por Bourneville

Autor: Jean-Martin Charcot (1825-1893).

Obra: *Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière*, tomo I, Lección XIII: «De l'hystéro-épilepsie».

Traducción: Cátedra de Psicopatología I, UFLO Online, 2026, directamente del original francés. El texto de Charcot es de dominio público.

Establecimiento del texto: ejemplar digitalizado de la edición tipográfica original (Internet Archive, id. b21922408).

Correspondencia con el programa: es el texto que J. Saurí recoge en *Las histerias* (Buenos Aires, Nueva Visión, 1984) bajo el título «Acerca de la hístico-epilepsia». La paginación de aquella edición **no coincide** con la de este documento.

Unidad: Unidad 2 — El síntoma y la histeria · Clase 5: Histeria y Dora: síntoma, fantasía y transferencia.

Nota sobre esta edición

Este documento reúne, en traducción castellana, el cuerpo de la Lección XIII de Charcot. Es un **recorte de cátedra**: se traduce íntegro el desarrollo doctrinario de la lección y se omiten las notas al pie de la edición original —protocolos de autopsia, cuadros termométricos y la transcripción completa de la observación de Wunderlich—, que son de interés médico-histórico pero no aportan a la discusión psicopatológica que nos ocupa. Las omisiones se señalan en su lugar.

Se conservan las abreviaturas de los nombres propios tal como figuran en el original (Co..., Ler..., Etchev..., Cheval...): Charcot designaba así a las enfermas del servicio. Los subrayados en cursiva reproducen los énfasis del original. Las intervenciones de la cátedra van siempre entre corchetes.

Por qué leemos este texto

Charcot discute aquí si la «hístico-epilepsia» nombra una entidad mixta —mitad histeria, mitad epilepsia— o si es histeria que toma prestada la forma exterior de la epilepsia. Su respuesta es la segunda, y el modo en que la funda importa más que la conclusión: no discute sobre las palabras ni sobre las doctrinas, sino que construye un **criterio diferencial observable** —la curva térmica— capaz de decidir entre dos hipótesis que el ojo clínico no distingue.

Ese gesto es el que Freud hereda y desplaza. Charcot lleva la histeria al rango de enfermedad legítima y le da un tipo clínico: una clínica de la mirada. Freud conservará la dignidad del síntoma hístico y abandonará el terreno donde Charcot lo fundaba, para preguntar por su sentido: una clínica de la escucha. Al leer a Dora conviene tener presente de dónde viene ese síntoma que ahora empieza a hablar.

Sumario de la lección [del original]

Hístero-epilepsia. — Sentido de esta denominación. — Opiniones de los autores. — Histeria epileptiforme, histeria de crisis mixtas. — Variedades de la hístero-epilepsia: hístero-epilepsia de crisis distintas; hístero-epilepsia de crisis combinadas o ataques-accesos. — Diferencias y analogías entre la epilepsia y la hístero-epilepsia. — Signos diagnósticos suministrados por el examen de la temperatura central en el estado de mal hístero-epiléptico y en el estado de mal epiléptico. — Estado de mal epiléptico: sus fases. — Caracteres clínicos del estado de mal hístero-epiléptico. — Gravedad de ciertos casos excepcionales de hístero-epilepsia. — Observación de Wunderlich.

DE LA HÍSTERO-EPILEPSIA

Señores:

En la breve descripción clínica que les he dado a propósito de cada una de las enfermas que pasaron ante sus ojos en nuestras últimas reuniones, he tenido cuidado de poner de relieve los principales caracteres que presentan los ataques convulsivos que padecen.

Han podido reconocer fácilmente que no se trataba en ellas de ataques vulgares, que entraran de golpe, sin discusión, en el tipo clásico. No es solamente por su intensidad que estos accidentes convulsivos se distinguen: es además por la forma que revisten; y lo que más impresiona al observador que presencia estos ataques es encontrar, entre las convulsiones clónicas de la histeria, ciertos rasgos más o menos pronunciados que recuerdan *la epilepsia*.

De hecho, la forma convulsiva que se observa en todas estas mujeres es la que se ha designado en estos últimos tiempos con el nombre de *hístero-epilepsia*; y adviértanlo bien: es la única forma que se encuentra en ellas. Todas estas mujeres no serían, pues, simplemente histéricas: serían hístero-epilépticas. ¿En qué difieren de las histéricas ordinarias? Este es un punto sobre el cual importa estar fijado, y para alcanzar ese objetivo les pido permiso para entrar en algunos desarrollos.

I. El sentido de la denominación

Ateniéndose a los términos mismos de la denominación puesta en uso —hístero-epilepsia— parece que no puede existir equívoco alguno. Quiere decir que en las enfermas a las que se aplica este nombre la histeria se muestra combinada con la epilepsia, de manera de constituir una forma mixta, una suerte de híbrido compuesto mitad de histeria y mitad de epilepsia. Pero ¿responde esta denominación a la realidad de las cosas? A miraras solo en la superficie, parece que así fuera, puesto que hemos reconocido en los ataques algunos de los rasgos de la epilepsia. De ese modo, por lo demás, parecen entenderlo la mayor parte de los autores modernos. La hístero-epilepsia sería para ellos una mezcla, una combinación, en dosis variables según los casos, de las dos neurosis; no es solamente la epilepsia, no es solamente la histeria: es a la vez la una y la otra.

Tal es, lo repito, la doctrina más difundida. Sin embargo, no es ni con mucho universalmente aceptada, y el campo de los opositores es todavía numeroso. Allí se rehúsa admitir la legitimidad de este híbrido, mitad epilepsia, mitad histeria.

A decir verdad, no se niega que la epilepsia y la histeria puedan encontrarse en un mismo individuo. La observación más superficial protestaría contra semejante aserción. Nada autoriza tampoco a creer que haya antagonismo entre las dos neurosis, y sería posible incluso —aunque ello no esté demostrado— que los sujetos afectados por una de ellas estuvieran, por eso mismo, predispuestos a contraer la otra. Pero en tal caso, se agrega, los accidentes convulsivos permanecen distintos, separados,

sin influirse recíprocamente de manera notable y sobre todo sin confundirse hasta el punto de justificar la creación de una especie mixta, intermedia, en una palabra, de un híbrido.

¿Cuál es, entonces, según esta opinión, la significación de esos ataques cuya existencia está tan netamente establecida por los casos mismos que sirven de fundamento a nuestro estudio, y donde la epilepsia parece entremezclarse con los síntomas ordinarios de la histeria convulsiva?

La epilepsia no estaría allí sino en la forma exterior; no estaría en el fondo de las cosas. En otros términos: en esos casos se trataría única y siempre de la histeria revistiendo la apariencia de la epilepsia. El nombre de *histeria epileptiforme*, empleado —si no me equivoco— por Louyer-Villermay, uno de los primeros, convendría para designar esos ataques mixtos. La convulsión de forma epiléptica aparecería allí como aparece en tantas otras afecciones del sistema nervioso, a título de elemento accesorio, sin cambiar en nada la naturaleza de la enfermedad primitiva.

II. La tesis que sostengo

He aquí, Señores, la tesis a la que me adhiero plenamente. Ha sido sostenida ya por algunos autores muy competentes. Entre ellos puedo citar a Tissot, Dubois (de Amiens), Sandras, el señor Briquet, que se muestran a este respecto muy explícitos. «Los accesos de histeria —dice Tissot— se parecen a veces mucho a la epilepsia. Por eso se ha hecho de ellos una forma particular de la histeria, bajo el nombre de *histeria epileptiforme*. Pero estos accesos no tienen, sin embargo, el verdadero carácter de la epilepsia.»

El señor Dubois (de Amiens) considera la histeria epileptiforme como una histeria que tiene un grado más en la intensidad de los síntomas. Sandras expresa la misma opinión.

El señor Briquet, que ha escrito sobre este tema un artículo marcado con el sello de la más sana observación, dice que esta especie de histeria de ataques mixtos no es más que una forma particular de la histeria; no es más que histeria muy intensa; el pronóstico no se encuentra esencialmente modificado; el género de la causa que ha ocasionado la histeria, las condiciones especiales del individuo afectado, serían la fuente de esas modificaciones en la forma de los ataques. La naturaleza misma de la histeria no queda por ello fundamentalmente cambiada.

Adviertan, Señores, que no hay allí solamente una cuestión de palabras: hay también *una cuestión de nosografía* y, por consiguiente, una cuestión de diagnóstico y de pronóstico. Estas circunstancias bastarán, así lo espero, para justificar ante sus ojos los detalles en los que me veo obligado a entrar a fin de hacer penetrar en sus espíritus la convicción que me anima al respecto.

III. Las variedades de la hístico-epilepsia

Investiguemos, pues, sobre qué fundamentos se apoya la doctrina reinante. La histeria y la epilepsia, se dice, pueden combinarse de diversas maneras en un mismo sujeto. Sobre 276 enfermas, el señor Beau, que ha estudiado en este hospicio, habría relevado esta combinación en 32 de ellas. Se produce según modos variados y cabe admitir las categorías siguientes.

A. En un primer grupo, los ataques hísticos y los accesos de epilepsia permanecen distintos: es lo que el señor Landouzy ha propuesto llamar *hístico-epilepsia de crisis distintas*. Pues bien, Señores, este sería el caso más frecuente, ya que se cuentan 20 ejemplos sobre los 32 casos del señor Beau. Conviene, por lo demás, establecer en la especie dos subdivisiones.

1.º La epilepsia es la enfermedad primitiva; sobre ella viene enseguida a injertarse la histeria, a su hora, es decir, las más de las veces en la época de la pubertad, bajo la acción de ciertas causas y, en particular, de las emociones morales.

Un caso de Landouzy, citado por el señor Briquet, merece a este propósito ser resumido ante ustedes. Una joven mujer, epiléptica desde la infancia, se casa a los 18 años. Pronto la enfermedad, que ella había disimulado, se revela. De ahí vivas contrariedades que engendran la histeria. Los ataques propios de las dos neurosis estaban disjuntos y conservaban, sin influirse, sus caracteres específicos. Un acercamiento entre la enferma y su marido, ocasionado por un embarazo, al devolver la calma al hogar, hace cesar la histeria; pero la epilepsia persiste.

2.º Otras veces la epilepsia sucede a la histeria. Esta condición parece ser mucho más rara que la precedente. El señor Briquet, sin embargo, refiere un ejemplo personal en el cual los accesos estaban netamente separados. En las enfermas de esta categoría la inteligencia se obnubila a la larga, incontestablemente, por el hecho de la epilepsia.

3.º Se han mencionado además otras combinaciones de orden secundario. Así: *a)* la histeria convulsiva coexiste con el *petit mal* (Beau, Dunant); *b)* la epilepsia convulsiva se sobreañade a algunos de los accidentes de la histeria no convulsiva (contractura, anestesia, etc.). Poseemos un caso de este género.

Pero estas diversas asociaciones no cambian en nada el fondo de las cosas. Las más de las veces, las dos afecciones, en la histero-epilepsia, existen simultáneamente y marchan sin actuar la una sobre la otra de manera seria, conservando cada una sus modos y el pronóstico que le es propio. Respecto de esta primera forma de la histero-epilepsia, todo el mundo está de acuerdo. *El debate no recae sino sobre la segunda.*

B. En esta, la histeria y la epilepsia son coeales: se han desarrollado al mismo tiempo. Las crisis, aquí, no permanecen distintas; no lo han sido nunca. Desde el origen la mezcla se ha efectuado, y en los ataques ulteriores las dos formas convulsivas se mostrarán siempre combinadas, aunque en grados diversos, sin estar jamás, en ningún momento, completamente disjuntas.

Se ha dado también a este estado el nombre de *histero-epilepsia de crisis combinadas*. En la jerga desde hace mucho usada en el servicio especial de la Salpêtrière, las crisis son en tal caso designadas con el nombre de *ataques-accesos*.

IV. ¿Hay verdaderamente epilepsia en las crisis mixtas?

Tal es la cuestión que debemos discutir ahora. A tal efecto, conviene tomar la descripción de la histero-epilepsia de crisis mixtas consentida por los autores y examinarla bajo todos sus aspectos. Tomo sobre todo del señor Briquet esta descripción del ataque-acceso. Me parece concordar en todos sus puntos con los resultados de mi observación personal.

a) Desde el origen, el ataque mixto reviste su carácter propio; desde ese instante, es histeria epileptiforme. Recordaré a su memoria a la enferma Etchev..., que en su primer acceso cayó en el fuego y se destrozó el rostro.

b) Hay siempre pródromos constituidos por el aura histérica tal como la hemos descripto. Esta aura, en general de larga duración, ocupa el abdomen, el epigastrio, y no afecta en todo caso la cabeza sola y de golpe, ni una de las extremidades, como ocurre en la *epilepsia con aura*; por eso es perfectamente exacto decir que las histero-epilépticas de crisis mixtas están casi siempre advertidas con tiempo suficiente como para poder, cuando se desarrolla un acceso, protegerse, encontrar un abrigo.

c) En el ataque convulsivo, la fase llamada epiléptica abre en general la escena. De pronto: grito, palidez extrema, pérdida del conocimiento, caída, distorsión de los rasgos de la fisonomía; luego una

rigidez tónica se apodera de todos los miembros. Esta rigidez es —advértanlo bien— rara vez seguida de sacudidas clónicas breves, de cortas oscilaciones y predominantes en un lado del cuerpo, como en la epilepsia verdadera. Sin embargo, la cara puede estar en alto grado tumefacta, violácea; fluye de la boca una espuma a veces sanguinolenta, ocasionada por la mordedura de la lengua o de los labios. Finalmente, puede haber una relajación general de los músculos, coma y una respiración estertorosa durante un lapso más o menos prolongado.

d) A esta primera fase —sobre la cual, lo repito, recae principalmente la discusión— sucede la fase clónica. *Entonces todo es histeria*: se ven sobrevenir los grandes movimientos de carácter intencional, contorsiones que expresan a veces las pasiones más variadas, el espanto, el odio, etc.; al mismo tiempo estalla el delirio del acceso.

e) El fin del ataque está marcado por sollozos, llantos, risas, etc.

Estas diversas fases no se siguen siempre de manera tan regular; se entremezclan a veces y ora la una, ora la otra, predomina. En la llamada C..., entre otras, la fase tónica se impone en alto grado sobre las demás y a veces se muestra casi exclusiva.

V. ¿En qué se separa de la histeria ordinaria?

Henos aquí llegados, Señores, al punto delicado. ¿En qué esta histeria de crisis complejas se separa de la histeria ordinaria, si es que realmente se separa de ella? ¿En qué se aproxima a la epilepsia verdadera, si cabe establecer tal aproximación?

¿Es acaso la aparición de convulsiones del tipo tónico un hecho nuevo, insólito, en la descripción clásica del ataque histérico vulgar? Ciertamente no. No es verdaderamente excepcional ver en el ataque de histeria común —cuando nadie piensa en hacer intervenir el elemento epilepsia— ver, digo, esbozarse convulsiones tónicas de carácter epileptiforme, particularmente al comienzo del ataque; todos los autores están de acuerdo sobre este punto. Estas convulsiones son a veces incluso tan acentuadas que el señor Briquet fue llevado por ello a establecer, al lado del ataque de histeria clónica o clásica, una suerte de ataque en el cual predomina una rigidez semitetánica del tronco y de los miembros. ¿No parece por ello ya muy verosímil que *la forma llamada epiléptica no sea, propiamente hablando, sino la exageración, el más alto grado de desarrollo de esa variedad de la histeria ordinaria?*

VI. Los rasgos que la separan de la epilepsia verdadera

Si por otro lado volvemos los ojos hacia la epilepsia verdadera, encontramos cierto número de rasgos distintivos que nos será fácil aprovechar.

Haremos notar, en primer lugar, que, según la descripción que hemos dado, el tipo epilepsia no está nunca representado en los ataques-accesos sino de manera incompleta y, por así decir, en estado de esbozo; pero, a decir verdad, esto no sería todavía un argumento perentorio. He aquí un carácter más significativo.

Jamás ven ustedes aparecer ni el *petit mal* ni el vértigo epiléptico en las descripciones de la histero-epilepsia de ataques mixtos. Podríamos agregar además —pues hay allí materia para una distinción importante— que en esta forma de la histero-epilepsia el ataque epileptiforme, aun el más intenso, resulta, según nuestras observaciones, modificado y a veces incluso detenido en su desarrollo por *la compresión del ovario*. Lo que no ocurre jamás —nos hemos asegurado de ello muchas veces— en la epilepsia verdadera.

En los ataques mixtos, aun cuando su retorno sea muy frecuente, jamás —he aquí también un hecho reconocido por los autores— jamás, digo, la obnubilación de la inteligencia y la demencia son el resultado final de los ataques, contrariamente a lo que ocurriría, de manera casi fatal, si se tratara realmente de epilepsia. Creo no poder hacer nada mejor que recordarles a este propósito el caso de la enferma Ler..., que desde hace cerca de 40 años está sujeta a la histeria epileptiforme más violenta. Esta mujer es, sin duda, extraña, singular en sus modos, pero su inteligencia ha permanecido tal como era en el origen. Los informes que hemos tomado no dejan subsistir ninguna duda al respecto. En suma, en los casos de este género —y tal es también la opinión del señor Briquet— *el pronóstico no es otro que el de la histeria intensa*. De esta consideración se desprende una consecuencia de orden práctico que bien puede fijar su atención.

Hay, finalmente, un último carácter sobre el cual les pido permiso para insistir, porque no ha sido, que yo sepa, señalado hasta ahora, y porque, según creo, es decisivo. Se trata de un carácter suministrado por *la exploración termométrica*: aprovecho, no sin diligencia, la ocasión que se presenta de mostrarles, con un nuevo ejemplo, el partido que puede sacarse de este modo de exploración en la clínica de las enfermedades del sistema nervioso.

VII. El criterio térmico

No es, Señores, que bajo la relación de las modificaciones impresas a la temperatura central las convulsiones tónicas epileptiformes de las histéricas difieran en nada de las convulsiones del ataque epiléptico. El ataque histérico tónico, por poco que tenga alguna intensidad, eleva la temperatura en un grado, incluso en un grado y algunas décimas (38°-38,5°), tal como lo hace el ataque de epilepsia verdadera. Es este un resultado cuya exactitud hemos tenido ocasión de controlar numerosas veces en este servicio.

Pero si, en lo que concierne al carácter térmico, el acceso de histeria epileptiforme y el acceso de epilepsia verdadera se confunden, ya no ocurre lo mismo cuando se trata de accesos que se agregan y se entrelazan de manera de constituir lo que, para la epilepsia, se ha llamado *las series* o el *estado de mal*.

Hay además, en ese estado de mal de los epilépticos, que distinguir lo que se denomina las *pequeñas series*, compuestas de 2 a 6 accesos, y las *grandes series*, en las que se cuentan hasta 18 o 20 accesos, o aun más, en las veinticuatro horas. Es a estas últimas a las que me dirigiré exclusivamente, porque el fenómeno sobre el cual quiero insistir se muestra entonces en su tipo de completo desarrollo. En tal caso, Señores, es decir, cuando los accesos de epilepsia verdadera se repiten en gran número en un corto espacio de tiempo, la temperatura central se eleva de manera muy notable; y muy ciertamente esta elevación térmica no puede ser atribuida exclusivamente a la repetición ni a la intensidad de las contracciones musculares tónicas, pues las convulsiones pueden cesar completamente durante varios días y la temperatura mantenerse, sin embargo, durante ese tiempo, en una tasa muy elevada.

No hay que ignorar que esta elevación de la temperatura es, en la gran mayoría de los casos, aun después de toda cesación de las convulsiones, un indicio del peor augurio; se acompaña por lo demás las más de las veces de un estado general que por sí mismo ya da mucho que pensar: así, ora existe un delirio más o menos acusado —que el señor Delasiauve atribuye a la congestión meníngea—, ora, por el contrario, un coma más o menos profundo —congestión apoplectiforme de los autores—; en ambos casos hay postración de las fuerzas, sequedad de la lengua, tendencia a la formación rápida de escaras en el sacro; a veces, en fin, producción de una hemiplejía transitoria cuya razón no ha sido revelada aún por la autopsia.

Sin embargo —y este es un dato muy importante de consignar—, esta elevación de la temperatura, aun cuando sobrepase los 41°, y aun cuando se acompañe de los síntomas graves que acaban de enumerarse, *no es un signo que anuncie necesariamente una terminación fatal*. Ven ustedes por la observación misma de Cheval... que se puede curar aún en medio de todas estas circunstancias desfavorables. La elevación de la temperatura por encima de 41° no es, pues, necesariamente terminal en tal caso; y hay por consiguiente algo que rebajar de las aserciones emitidas al respecto por el señor Wunderlich primero, y después de él por el señor Erb.

[La edición original despliega aquí, en nota, el protocolo completo de la enferma Cheval... —recuento de accesos, curvas de temperatura y autopsia— que se omite en este recorte.]

Les recordaré, de paso, que esta elevación rápida de la temperatura no pertenece en propio, ni mucho menos, al estado de mal epiléptico; se la observa también, por ejemplo, en los ataques llamados congestivos, apoplectiformes o epileptiformes de la parálisis general progresiva, tal como lo mostró primero el señor Westphal. Se la observa asimismo en los ataques muy análogos a los precedentes que pueden sobrevenir en el curso de la esclerosis en placas y, finalmente, en los ataques, con o sin convulsiones, que se observan en los casos de foco cerebral antiguo —hemorragia o reblandecimiento— o de tumor cerebral, cualquiera sea su naturaleza. Esta elevación térmica contrasta de manera notable con el descenso inicial que existe casi siempre en el momento de la formación del foco hemorrágico cerebral, y es este, tal como lo he demostrado, un carácter que puede ser utilizado para el diagnóstico.

VIII. El estado de mal hístico-epiléptico: la enferma Co...

Pero es tiempo de volver a la histeria epileptiforme, de la que esta digresión nos ha alejado un poco. Tal como en la epilepsia verdadera, los accesos pueden acumularse en la hístico-epilepsia. Landouzy habla de una hística que había tenido hasta 100 accesos por día; y el estado de mal puede por lo demás prolongarse durante un lapso considerable. Georget cita la observación de una mujer en la cual los accesos se mostraron casi continuos durante cuarenta y cinco días.

En nuestra enferma Co..., cuyas crisis tienen un carácter epileptiforme tan predominante y tan fuertemente acentuado, *el estado de mal ha persistido durante más de dos meses* y, por momentos, los accidentes han sido llevados al más alto grado de intensidad. Así, el 22 de enero, entre otros, las convulsiones epileptiformes se sucedieron sin interrupción desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche: de ocho a nueve hubo un tiempo de reposo, luego los ataques se reanudaron con más fuerza, sin el menor retorno a la lucidez, y persistieron aproximadamente durante el mismo espacio de tiempo. Se puede, de manera aproximada, evaluar sin exageración la cifra de los ataques epileptiformes que experimentó en esa época, en el espacio de un día, en 150 o 200 aproximadamente.

La persistencia de semejante estado, sin que la muerte se haya seguido, ¿no muestra ya que *un abismo separa la epilepsia verdadera de la hístico-epilepsia?*

«Si esto no fuera histeria —decían, hablando de Co..., las cuidadoras del servicio, testigos de sus accesos y habituadas a esta clase de enfermas—, si fuera epilepsia verdadera, hace mucho tiempo que esta mujer habría sucumbido.» Esta observación es perfectamente juiciosa, perfectamente fundada.

Pues bien, Señores —y he aquí el punto sobre el cual quiero sobre todo insistir—, jamás durante ese largo período convulsivo la temperatura rectal se modificó sensiblemente en Co...: fue en promedio de 37,8; solo se elevó hasta 38,5 de una manera del todo excepcional y transitoria. Debo agregar que jamás durante ese tiempo el estado general nos inspiró la menor inquietud, pese a la alimentación insuficiente

y al enorme gasto de fuerza muscular que debió producirse. La situación mental, por otro lado, no estaba, ni con mucho, tan profundamente modificada como habría ocurrido necesariamente si se hubiera tratado de la verdadera epilepsia; en ninguna época hubo evacuaciones involuntarias de orina o de materias fecales; en las cortas treguas que le dejaban sus ataques, la enferma se levantaba para satisfacer sus necesidades. En esos intervalos, por lo demás muy cortos, la naturaleza histérica del mal, sobre todo en las primeras semanas, reaparecía en todo su esplendor. Una flor en los cabellos, rizos extraños, un viejo pedazo de espejo colocado sobre la tablilla de la cama, atestiguaban suficientemente las ocupaciones favoritas de esta mujer en los tiempos de tregua.

Pero quiero sobre todo señalar a su atención el carácter térmico que la observación nos ha hecho reconocer. Resultaría, en suma, de todo lo que precede, que si en el *estado de mal epiléptico de grandes series* la temperatura se eleva muy rápidamente a un alto grado, al mismo tiempo que la situación se vuelve de las más graves, por el contrario, en el *estado de mal hístico-epiléptico de larga serie* la temperatura apenas sobrepasa la cifra normal, y por lo demás el estado general concomitante no es de naturaleza tal que inspire inquietud. No es necesario insistir largamente, pienso, para poner de relieve un contraste tan llamativo.

IX. El capítulo de las excepciones: la observación de Wunderlich

No querría sin embargo, Señores, que tomaran absolutamente al pie de la letra el último término de la proposición que acabo de emitir; sin duda responde a la realidad para la gran mayoría de los casos, pero está el capítulo de las excepciones. No carece, en efecto, de ejemplos que la histeria haya terminado por la muerte durante la fase convulsiva. A decir verdad, son casi siempre ataques de un género particular, ataques disneicos, los que acarrearán ese triste resultado; pero, lo repito, los ataques convulsivos mismos pueden conducir a ello. Puedo, a título de ejemplo, recordarles un hecho de este género publicado por el señor Wunderlich. Se trata de un caso de hístico-epilepsia comparable en muchos aspectos a aquel del que acabo de hablarles. Durante más de ocho semanas la enferma en cuestión experimentó ataques epileptiformes, en número por lo demás bastante restringido, y que no se acompañaban de aumento notable de la temperatura; sin causa conocida, sin la intervención de accidentes nuevos, dos días antes de la muerte la escena cambió de pronto: la enferma cayó en el colapso, y en un corto espacio de tiempo la temperatura se elevó hasta 43°.

[Sigue en el original la transcripción completa de la observación de Wunderlich —la joven Anna Vogel, de 19 años— con su protocolo día por día y la autopsia. Se omite en este recorte.]

Este ejemplo bastará, Señores, para mostrarles que ante un caso de estado de mal hístico-epiléptico de alguna intensidad, pese a todas las probabilidades de un desenlace favorable, no sería prudente abandonarse a una seguridad completa, absoluta.

[Fin del cuerpo de la Lección XIII.]

Apéndices documentales

Las dos observaciones que siguen figuran en la edición original como notas al pie de esta misma lección. Son los protocolos sobre los que Charcot apoya su argumento: el primero muestra el estado de mal *epiléptico* con su curva térmica ascendente; el segundo, la excepción que obliga a la prudencia. Se traducen aquí sus partes clínicas; de los informes de autopsia se ofrece una síntesis.

Apéndice A · La enferma Cheval... (nota de Bourneville)

Charcot invoca esta observación para sostener que una temperatura superior a 41° no es necesariamente terminal. Bourneville agrega en nota el desenlace posterior, ocurrido al año siguiente.

9 de febrero de 1873. Desde hace aproximadamente una semana, Ch... está irritable, molesta; por momentos se vuelve violenta hasta el punto de que es necesario sujetarla (excitación maníaca).

10 de febrero. La noche pasada la agitación aumentó todavía: Ch... impidió con sus gritos dormir a las otras enfermas. Se calmó, sin embargo, a partir de las tres de la mañana. Se contaron tres accesos durante la noche. De la una a las tres de la tarde, los accesos se multiplicaron. A las tres: pulso 101; temperatura rectal 38,6.

11 de febrero. Ayer, de la una a las nueve de la noche, se contaron 43 accesos; desde entonces hasta esta mañana a las siete, 70 accesos. De siete a once, momento en que se tomó esta nota, 33 accesos.

He aquí la descripción de los accesos: cinco o diez segundos antes de su llegada, las pupilas —sobre todo la derecha— se dilatan ampliamente. A veces se agregan a este fenómeno pequeñas quejas, rechinar de dientes y, por excepción, un grito leve. Entonces comienza el acceso: los globos oculares son animados por convulsiones muy acusadas (nistagmo), la cara palidece y se desvía hacia la izquierda; la mirada, al principio fija y dirigida hacia adelante, se lleva hacia la izquierda. El brazo correspondiente se levanta, luego se pone rígido al mismo tiempo que el brazo derecho, que permanece apoyado sobre la cama. La rigidez tetánica gana enseguida los miembros inferiores. Al cabo de algunos segundos se observa una semioclusión de los párpados izquierdos, que son animados —así como los músculos de la misma mitad de la cara— por convulsiones rápidas.

Diez o quince segundos más tarde, la cara y los ojos giran hacia la derecha; el tronco se inclina en el mismo sentido; los párpados izquierdos se entreabren y permanecen casi inmóviles; pero, en cambio, las convulsiones se apoderan de los párpados derechos y de los músculos de la mitad derecha de la cara. La boca, primitivamente tirada hacia la izquierda, es tirada hacia la derecha. Las convulsiones clónicas aparecidas durante esta fase, que habrían invadido primero los miembros del lado izquierdo, predominan ahora a la derecha.

Finalmente, el acceso termina con ronquidos, una lividez facial lo más pronunciada posible, espuma en la boca. Al fin del acceso, las pupilas recuperan sus dimensiones normales.

Durante las remisiones, la enferma está en resolución completa. Levantados, los miembros vuelven a caer inertes. A las once: pulso 110; respiración 40, ruidosa; temperatura rectal 40,8. Al mediodía: pulso 130; respiración 60.

Seis de la tarde. Desde las once de la mañana se han registrado 76 accesos, de los cuales 13 desde las cuatro. Respiración 60; temperatura rectal 41,2. Sudores copiosos sobre todo el cuerpo, sin diferencia entre las dos mitades. Toda la parte izquierda del cuerpo —cara, tronco— está manifiestamente más caliente que la parte derecha. Los párpados están entreabiertos; los ojos, dirigidos hacia arriba; las pupilas, moderadamente dilatadas (la derecha lo está siempre más). Antes de cada acceso, la dilatación de las pupilas se acrecienta de manera notable. Coma. Respiración estertorosa.

Ocho de la noche. Respiración 70; temperatura rectal 41,2. Catorce accesos. A partir de ese instante la enferma no tuvo más accesos. Murió a las tres de la mañana. La temperatura vaginal, tomada por otra persona, era de 41,2. A las once de la mañana —es decir, ocho horas después de la muerte— la temperatura rectal era de 40°.

Autopsia, 13 de febrero. [Síntesis del original.] Huesos, duramadre y sus senos, sin anomalías; la cantidad de líquido cefalorraquídeo no está aumentada. Sufusión sanguínea sobre la cara convexa de los hemisferios, sobre todo a la derecha. Arterias de la base, sanas. Encéfalo: 1.360 gramos. Se consigna una induración evidente de la circunvolución

del asta de Ammón, más marcada en el hemisferio derecho. Congestión de la mitad inferior de los pulmones con un foco de hepatización roja reciente. Corazón, estómago y bazo, sanos. Útero algo grande; cuerpo amarillo reciente en uno de los ovarios, pequeños quistes en el otro.

Apéndice B · La observación de Wunderlich

Es el caso que Charcot invoca como excepción: ocho semanas de convulsiones histeriformes de marcha apirética y sin peligro aparente, y un vuelco súbito y fatal sin que las convulsiones hubieran aumentado de intensidad.

Anna Vogel, 19 años, sirvienta, menstruada dos veces en los últimos catorce días antes de caer enferma y por lo demás sana, fue tomada por primera vez el 13 de agosto de 1855 —según se dice, tras una viva reprimenda— por convulsiones que se repitieron el 17 por la noche y el 18 por la mañana, y que llenaron casi sin interrupción la noche del 18 al 19.

Ingresada el 19 al mediodía, presentó a medianoche, en el brazo izquierdo —donde se había constatado parálisis, pero no insensibilidad—, sobresaltos moderados; luego experimentó un sentimiento de angustia, lanzó un grito leve y tuvo convulsiones primero en la mitad izquierda de la cara y después también en la derecha; la boca estaba abierta, los párpados alternativamente abiertos y cerrados, el globo ocular fuertemente vuelto hacia arriba. Sobrevinieron luego, en las extremidades inferiores y la pelvis, violentas y rápidas convulsiones clónicas que proyectaban esas partes hacia adelante, hacia atrás y de costado. La cara se puso cianótica y la espuma salió de la boca. Al cabo de un minuto, respiración profunda y relajación de los miembros y de la cara. Enseguida, sueño en apariencia apacible; finalmente bostezo, apertura de los ojos y retorno de la conciencia a los seis minutos.

La enferma está en buen estado, su lengua algo saburral; la temperatura es de 38,4; el pulso, de 140 después del acceso; nada anormal. Dice solamente no poder mover el brazo izquierdo, y pide que no se lo toquen porque de otro modo tendría convulsiones.

En la noche del 19 al 20, 6 accesos, y durante el día 20, siete. Sin albúmina en la orina. Temperatura, mañana y noche, 38,12; pulso 132. En la noche del 20 al 21, 7 accesos, y 13 hasta la mañana del 22; temperatura 37,75.

Los días siguientes, de 8 a 16 accesos por día. Estado por lo demás soportable; sin elevación notable de la temperatura —las más de las veces normal, jamás por encima de 38,12, salvo una noche a 38,75—; pulso ordinariamente por encima de 112. En los accesos, unas veces pierde el conocimiento, otras no; grita mucho a veces. La sensibilidad persiste en el brazo y la pierna izquierdos.

7 de septiembre. Los accesos se vuelven más frecuentes, duran varios días sin interrupción; durante los accesos habla a menudo y grita. Evacuaciones frecuentes en la cama. Mejoría, luego estado estacionario hasta la noche del 2 de octubre, en que la enferma presenta un acceso de colapso marcado.

En la noche del 3, ningún acceso particular. Por la mañana, agitación de los brazos, estrabismo divergente. La cabeza se inclina hacia adelante y a la izquierda, conciencia conservada, ligera cianosis. A partir de las diez, imposibilidad de tragar; al mediodía, trismus; a la una y tres cuartos, fuertes convulsiones que respetan la cabeza; pulso extremadamente frecuente; temperatura 41,87; fuerte cianosis, espuma en la boca, estertor traqueal. **Muerte a las dos y cuarto; temperatura 43°.** Un cuarto de hora después, 42,75.

Autopsia. [Síntesis del original.] Cuerpo en buen estado; amplias manchas cadavéricas en las zonas declives; sin rigidez muscular. Cráneo y vísceras congestionados de sangre; circunvoluciones posteriores algo aplanadas; sustancia cerebral algo dura. Ligero engrosamiento turbio de la piamadre de la base. Pulmones congestionados y edematizados. Corazón normal; hígado graso en partes. Bazo pequeño y exangüe. Riñones fuertemente congestionados. Útero normal; quistes numerosos, del tamaño de un guisante, en los ovarios.

[Nota de la traducción: el ejemplar digitalizado presenta errores de reconocimiento en algunas cifras de este protocolo —el dígito 4 se lee como 1—. Se han restituido a partir del propio texto de Charcot, que en el cuerpo de la lección consigna expresamente que la temperatura llegó a 43°.]

Aparato de cátedra

Lo que sigue no pertenece a Charcot: es material de la cátedra para orientar la lectura.

Quién es quién en la lección

- **Briquet, Pierre** (1796-1881): autor del *Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie* (1859), el gran tratado estadístico sobre la histeria previo a Charcot. Es su interlocutor principal en esta lección.
- **Landouzy, Hector** (1812-1864): a él se debe la expresión «hístico-epilepsia de crisis distintas».
- **Louyer-Villermay, Jean-Baptiste** (1776-1837): a quien Charcot atribuye el uso temprano de «histeria epileptiforme», el término que él prefiere.
- **Wunderlich, Carl** (1815-1877): pionero de la termometría clínica. Charcot usa su propio instrumento —el termómetro— para corregirlo.
- **Bourneville, Désiré-Magloire** (1840-1909): discípulo de Charcot, responsable de recoger y publicar estas lecciones.

Cuatro cosas para tener localizadas

Punto de la lección	Qué sostiene Charcot	Por qué importa para la Clase 5
El estatuto de la «hístico-epilepsia»	No es una entidad híbrida ni una transición hacia la epilepsia: es histeria que toma la <i>forma exterior</i> de la epilepsia. De ahí que prefiera «histeria epileptiforme».	La forma del síntoma no da su naturaleza. Es el principio que Freud llevará más lejos: el síntoma no se lee por su apariencia sino por su determinación.
El criterio térmico	En el ataque aislado, ambas suben igual. La diferencia aparece en el estado de mal: la epilepsia verdadera dispara la temperatura; la hístico-epilepsia no (Co...: 37,8 de promedio durante más de dos meses).	Un criterio que decide entre dos hipótesis cuando la observación directa no alcanza. El modelo de rigor que Freud reclamará para la causalidad psíquica.
La compresión ovárica	Modifica o detiene el ataque hístico, nunca el epileptico.	Un signo que hoy leemos de otro modo: la crisis responde a la intervención del médico. Charcot lo anota como dato objetivo; Freud se preguntará qué significa que el síntoma responda a otro.
El pronóstico	Nunca termina en demencia (la enferma Ler..., 40 años de crisis violentas, conserva intacta su inteligencia). El pronóstico es el de la histeria intensa.	Separa el destino de la histeria del de las afecciones deficitarias, y la habilita como terreno de un tratamiento que no sea custodia.

Preguntas para llevar a clase

1. ¿Por qué Charcot dice que la discusión sobre el nombre «hístico-epilepsia» no es una cuestión de palabras sino de nosografía? ¿Qué se juega en el pronóstico?
2. Charcot construye un criterio diferencial que no depende de lo que se ve en el ataque. ¿Cuál es, y por qué le hace falta salir de la descripción?

3. La enferma Co... se arregla el pelo y guarda un pedazo de espejo entre crisis y crisis. ¿Por qué Charcot anota ese detalle en una argumentación sobre temperatura?
4. Charcot le devuelve a la histérica la dignidad de enferma verdadera al equipararla a una afección del sistema nervioso. ¿Qué gana y qué pierde el síntoma en esa operación? Guardá la pregunta para cuando leamos a Dora.

Sobre esta traducción

Traducida directamente del francés por la cátedra, sin intermediación de otra versión castellana. Se ha buscado conservar el registro oral de la lección —Charcot habla a un auditorio y lo interpela— antes que modernizar su sintaxis. Los términos técnicos se mantienen en la forma de época (*estado de mal*, *petit mal*, *aura*, *ataque-acceso*), con la grafía «hístico-epilepsia» que usa la bibliografía castellana de la materia.

El original francés de esta lección está disponible para control en el ejemplar digitalizado de Internet Archive (id. *b21922408*), tomo I, Lección XIII, «De l'hystéro-épilepsie».